

Datos Personales							
Nombre:	ANDREA PAOLA SALCEDO VILORIA	Sexo Biológ.:	M	F. Nacimiento:	1996-06-13	Edad	29 Años, 8 Meses, Y 13 Días
Identificación:	CC - 1065825839	Lateralidad:	Diestro	Estado Civil:	UnionLibre	Ocupación:	INGENIERA
Correo Electrónico:	Andreasalcedo576@gmail.Com - 1065825839			Dirección:	MZ E CASA 12 A Conjunto Cerrado Acuarela		
Departamento:	CESAR		Municipio:	VALLEDUPAR		Zona:	Urbana
Empresa:	Particular						

Apertura psicología del 2026-02-24 10:53:07: 29 años, 8 meses, y 13 días

DATOS GENERALES

Remisión

Autorreferido (Particular)

DX principal

NREF - NO REFIERE

DX Relacionado 1

NREF - NO REFIERE

DX Relacionado 2

NREF - NO REFIERE

Código de consulta

890208 - CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR PSICOLOGIA

Motivo de Consulta

La paciente refiere, "Fue una decisión en mutuo acuerdo con mi esposo de venir, vine porque tengo un mes sentirme así con un agotamiento físico, emocional, mental. Me he vuelto muy irritable, poco tolerable ante las situaciones".

Enfermedad Actual

Paciente femenina de 29 años, madre de dos hijos, quien consulta por sintomatología de aproximadamente un mes de evolución caracterizada por agotamiento físico, emocional y mental, acompañado de incremento en irritabilidad, llanto fácil y sensación de desbordamiento emocional.

Refiere antecedentes de maternidad temprana, con primer embarazo a los 19 años, contexto que describe como altamente vulnerable a nivel económico y emocional, con experiencias de juicio social y vivencias de humillación, las cuales identifica como eventos significativos en su historia personal. Posteriormente establece nueva relación de pareja estable, con quien tiene su segundo hijo, actualmente de 13 meses. En la actualidad, describe sobrecarga asociada al rol materno y doméstico, en contexto de limitada red de apoyo. Refiere que su esposo tiene dinámicas laborales por turnos (5x2), permaneciendo la mayor parte del tiempo sola a cargo del cuidado de ambos hijos y responsabilidades del hogar, además de apoyo indirecto en emprendimiento familiar (pizzería).

Señala que el hijo menor presenta alta demanda de contacto físico, con dificultad para separarse de la madre, despertares frecuentes y llanto persistente, lo que ha incrementado su nivel de agotamiento. La paciente refiere hipersensibilidad al llanto del menor, asociada a antecedentes personales de migraña, lo cual favorece conductas de sobreprotección (evita dejarlo llorar, lo mantiene en brazos de forma prolongada), reforzando un patrón de dependencia. Describe sentimientos ambivalentes frente a la maternidad actual, manifestando culpa al experimentar deseos de descanso o necesidad de espacios personales, verbalizando autorreproches (“me siento como la peor mamá del mundo”). Refiere episodios recientes de llanto intenso ante situaciones cotidianas, asociados a sensación de soledad y necesidad de contención emocional por parte de la pareja. En relación con la dinámica familiar, refiere cambios emocionales asociados al proceso evolutivo de la hija mayor, quien ha iniciado mayor independencia, generando sentimientos de pérdida simbólica del vínculo de dependencia previo. Asimismo, expresa malestar por la percepción de cambios en su autoimagen corporal tras el embarazo, asociando aumento de peso con disminución en autoestima y autocuidado.

La paciente refiere tendencia a la rumiación cognitiva, inseguridad en la expresión emocional y dificultades en comunicación asertiva, reconociendo patrones de sobrepensamiento persistente. Identifica que estas características podrían estar relacionadas con experiencias tempranas de invalidación y vulnerabilidad en su historia personal. Niega red de apoyo familiar constante para el cuidado del menor, refiriendo que sus familiares cercanos se encuentran laboralmente activos, lo que limita la posibilidad de delegar funciones de cuidado. La sintomatología descrita se ha intensificado en el último mes, con sensación persistente de agotamiento, deseo de aislamiento ocasional, episodios de llanto y percepción de pérdida de bienestar emocional.

ANTECEDENTES

Médicos Personales

Quirúrgico

Cesáreas

Traumáticos

Ninguno

Paraclínicos

Ecografías

Patología

Migraña Desde Los 13 Años.

Tóxicos

Medicación

No Refiere.

Hospitalizaciones

Si, Cálculos En Los Riñones.

ANTECEDENTES

Médicos Familiares

Depresión No Refiere	Ansiedad No Refiere
Demencia No Refiere	Alcoholismo No Refiere
Drogadicción No Refiere	Discapacidad Intelectual No Refiere
Patológicos TDA Sobrino	Otros Cáncer Aquela Materna

Áreas de Ajuste y/o Desempeño

Historia educativa

La paciente es profesional en ingeniería geológica, con especialización en geotecnia ambiental, graduada en 2019. Durante su proceso formativo refiere adecuado desempeño académico y habilidades sociales funcionales, destacando facilidad para establecer relaciones interpersonales en contextos educativos.

Historia laboral

La paciente refiere que actualmente supervisa un emprendimiento familiar de pizzería con aproximadamente cinco años de trayectoria y crecimiento sostenido. Señala que ha decidido no ejercer su formación profesional, orientándose al ámbito empresarial, donde reconoce habilidades resolutivas y administrativas funcionales.

Historia familiar

La paciente convive actualmente con su esposo, el señor Elkin Romero (36 años), su hija mayor, Salomé Chamorro (10 años), y su hijo menor, Valentín Romero (13 meses). Describe dinámica familiar cohesionada, caracterizada por vínculos afectivos cercanos y colaboración mutua en las responsabilidades cotidianas. Refiere percepción positiva de su rol parental, identificando prácticas de crianza basadas en afecto, responsabilidad y acompañamiento constante. A nivel relacional, identifica discrepancias en el estilo afectivo con su esposo, a quien percibe como emocionalmente más práctico y orientado a soluciones, mientras ella se reconoce como altamente sensible y con necesidad de validación emocional. Manifiesta dificultad para expresar necesidades, delegar responsabilidades o solicitar apoyo, lo cual incrementa su carga subjetiva.

Historia social

La paciente refiere facilidad para establecer relaciones interpersonales e integrarse en distintos contextos sociales; sin embargo, señala dificultad para mantener vínculos a largo plazo, atribuyéndolo principalmente a distanciamiento progresivo asociado a sus múltiples responsabilidades y ocupaciones cotidianas.

Historia emocional/afectiva

La paciente refiere proceso de elaboración emocional posterior a ruptura de relación de pareja previa, describiendo inicialmente dificultades para establecer confianza en su vínculo actual, caracterizadas por actitud defensiva y reserva afectiva ante temor de nuevas pérdidas. Señala que, con el tiempo, ha desarrollado mayor sensación de seguridad en la relación actual. No obstante, actualmente identifica limitaciones en la expresión emocional, especialmente en la comunicación de preocupaciones o malestar, tendiendo a la inhibición afectiva y evitación del conflicto, con preferencia por el silencio ante experiencias percibidas como desprecio o invalidación.

Historia deportiva

La paciente refiere reinicio reciente de actividad física, con asistencia al gimnasio desde hace aproximadamente una semana, en el contexto de búsqueda de mejora en su bienestar físico y emocional.

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA

Evaluación psicológica inicial

Se realiza evaluación psicológica mediante entrevista clínica semiestructurada orientada a la exploración de áreas de ajuste actual, red de apoyo, factores protectores y factores de riesgo. Durante la valoración se emplean técnicas de observación clínica y escucha activa, facilitando espacio de expresión emocional, con intervención de contención y catarsis ante desbordamiento afectivo. Se indaga temporalidad de la sintomatología, la cual la paciente asocia al periodo posparto. Se identifican manifestaciones de sobrecarga emocional con impacto en su funcionamiento cotidiano, especialmente en el rol materno y en espacios de autocuidado. A nivel clínico, se plantea hipótesis inicial compatible con agotamiento emocional en contexto de demandas parentales elevadas y limitada red de apoyo. La paciente muestra adecuada disposición al proceso terapéutico, con nivel de introspección conservado y motivación para el cambio, reconociendo necesidad de acompañamiento psicológico.

Interconsultas e Intervenciones

Intervención psiquiátrica

No refiere.

Intervención neurológica

No refiere.

Intervención neuropsicológica

No refiere.

Otras intervenciones

No refiere.

EXAMEN MENTAL

Examen Mental

La paciente ingresa a consulta con adecuado contacto inicial, saludo espontáneo y presentación personal acorde al contexto. Se encuentra orientada en las tres esferas (auto y alopsíquicamente), alerta, vigil y colaboradora durante la entrevista. Atención y concentración conservadas. Lenguaje fluido, coherente y organizado. Pensamiento lógico, sin alteraciones formales; contenido del discurso congruente con el motivo de consulta. Afecto lábil, con llanto fácil durante la narrativa de experiencias recientes, evidenciando reactividad emocional acorde al contenido verbalizado. Refiere sentimientos de frustración y tristeza asociados a sobrecarga emocional y rol materno. Ánimo subjetivamente disminuido, con sensación persistente de agotamiento emocional. No se evidencian ideas delirantes ni alteraciones senso perceptivas. Niega ideación suicida o autolesiva actual. Juicio de realidad conservado. Insight presente, con reconocimiento del malestar psicológico y de la necesidad de acompañamiento terapéutico. Actitud receptiva y adecuada disposición al proceso psicoterapéutico.

Ciclos del Sueño

Alterado. La paciente refiere patrón de sueño fragmentado desde el nacimiento de su hijo menor, con descanso promedio aproximado de 2 horas continuas y múltiples despertares nocturnos. Describe sensación de sueño no reparador, compatible con privación de sueño sostenida.

Apetito

Aumentado desde el último año, asociado a percepción subjetiva de incremento de peso.

Actividades de Autocuidado

Conservadas. La paciente mantiene independencia funcional en actividades básicas de autocuidado, aunque refiere disminución en espacios personales de bienestar.

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA

Impresión Diagnóstica (CIE 10 - DSM-V):

F432 - TRASTORNOS DE ADAPTACION

Impresión Diagnóstica Relacionada 1

F43.23 - TRASTORNO DE ADAPTACIÓN, CON ANSIEDAD MIXTA Y ESTADO DE ÁNIMO DEPRIMIDO

Impresión Diagnóstica Relacionada 2

NREF - NO REFIERE

Establecido por primera vez

Si

Objeto de atención clínica

NO REFIERE

PLAN DE INTERVENCIÓN

Plan de Intervención

Objetivo General

Favorecer la regulación emocional y el restablecimiento del bienestar psicológico mediante la disminución de la sobrecarga materna, fortalecimiento de recursos de afrontamiento adaptativo y reorganización de dinámicas de autocuidado y apoyo, en el marco de sintomatología ansioso-depresiva asociada a proceso adaptativo vital.

Objetivos Específicos

- Disminuir la intensidad de sintomatología ansiosa y afectiva mediante estrategias de regulación emocional basadas en evidencia.
- Abordar la sobrecarga asociada al rol materno, promoviendo reestructuración cognitiva de creencias disfuncionales relacionadas con culpa y autoexigencia parental.
- Favorecer la recuperación progresiva de patrones de sueño funcionales mediante psicoeducación en higiene del sueño y estrategias de regulación fisiológica.
- Fortalecer habilidades de comunicación asertiva para la expresión de necesidades emocionales y solicitud de apoyo en el entorno conyugal y familiar.
- Promover el restablecimiento de espacios de autocuidado y reconexión con identidad personal más allá del rol materno.
- Disminuir patrones de rumiación cognitiva mediante técnicas de atención plena y reestructuración cognitiva.
- Fortalecer red de apoyo y recursos protectores, facilitando procesos de delegación progresiva en tareas de cuidado.
- Prevenir cronificación del cuadro mediante seguimiento terapéutico continuo y detección temprana de factores de riesgo emocional.

Sugerencias e Interconsultas

Acompañamiento en orientación familiar: para fortalecimiento de dinámicas de apoyo y corresponsabilidad en la crianza.

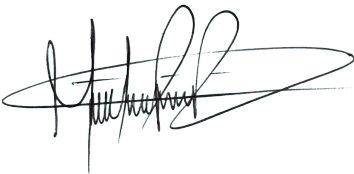
Observaciones y Recomendaciones

OBSERVACIONES

- La paciente presenta adecuado insight y motivación para el cambio, lo cual constituye factor pronóstico favorable.
- Se evidencia relación significativa entre privación de sueño y exacerbación sintomática.
- La sobrecarga materna en contexto de limitada red de apoyo actúa como factor mantenedor principal.
- Se identifican recursos personales conservados, incluyendo capacidad reflexiva, vinculación afectiva adecuada y disposición terapéutica.

SUGERENCIAS

- Dar continuidad a proceso psicoterapéutico individual con frecuencia inicial semanal.
- Implementar rutinas progresivas de autocuidado, priorizando descanso y espacios personales breves pero consistentes.
- Favorecer acuerdos con la pareja orientados a corresponsabilidad en el cuidado del hijo menor.
- Establecer microespacios diarios de regulación emocional (respiración consciente, pausas activas).
- Promover flexibilización de autoexigencias asociadas al rol materno, favoreciendo enfoque de maternidad suficientemente buena.
- Monitorear evolución del patrón de sueño como indicador clínico de mejoría.
- Evitar aislamiento emocional, promoviendo vínculos de apoyo significativos.
- Revalorar clínicamente en caso de incremento de síntomas afectivos o deterioro funcional.



DRA. MARIA ISABEL PUMAREJO

Psicóloga clínica
Tarjeta Profesional: 259542
Mag. TP3G - VIU

